
Secretaria da Saúde de Joinville
Gerência de Gestão Estratégica
Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde

Nota Técnica GGE/NARAS nº 01/2019

Assunto: Solicitação do Exame Laboratorial de Curva de Lactose

Considerando que o Exame Laboratorial Curva de Lactose não pertence à Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Tabela SIGTAP / SUS) o Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde (NARAS), a Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório (GAFL) e a Diretoria Técnica Médica elaboram esta Nota Técnica referente a Solicitação do Exame Laboratorial Curva de Lactose.

Intolerância à Lactose

A intolerância à lactose pode ser descrita como uma afecção da mucosa intestinal que a incapacita a digerir a lactose devido à ausência de uma enzima intestinal denominada lactase (PEREIRA FILHO; FURLAN, 2004). Essa enzima é responsável pela hidrólise da lactose em dois monossacarídeos, glicose e galactose, o que facilita a absorção desse principal glicídio do leite, sendo usada como fonte de energia para o organismo (PORTO; THOFEHRN; SOUSA; CECAGNO, 2005).

A lactose é encontrada no leite animal e derivados. A lactose aumenta a pressão osmótica no intestino grosso, pois retém certa quantidade de água, dando origem a sintomas como excesso de gases e diarreia osmótica. Devido à fermentação da lactose no intestino grosso, podem ser observados sinais como a produção de ácido láctico e gases como o gás carbônico e hidrogênio, sendo estes comumente utilizados nos testes de determinação de intolerância. Há ocorrência de distensão abdominal e excessiva eliminação de flatos, seguidos ou não de fezes amolecidas ou fraca diarreia aquosa com fezes ácidas e assadura perianal, podendo ocorrer desidratação e acidose metabólica. Existem casos de alterações no esvaziamento gástrico e ainda podem ocorrer casos de desnutrição devido à má absorção intestinal, dependendo da intensidade e constância de cada caso (TÉO, 2002).

A intolerância à lactose pode ocorrer em qualquer idade, é extremamente raro ser intolerante à lactose desde o nascimento. Nas crianças, a intolerância à lactose se torna mais comum após os 5 anos de idade. A maioria das crianças tem lactase quando nasce e pode digerir lactose enquanto bebês. A lactose é o açúcar principal do leite materno. Se uma infecção ou alergia alimentar afetar o intestino delgado, a criança pode desenvolver intolerância à lactose, causando uma redução da

lactase. Normalmente, esse dano é temporário, porém pode levar semanas, ou até meses, até que a criança consiga tolerar leite e seus derivados novamente. Doenças crônicas como a doença celíaca, a doença de Crohn ou infecções com parasitas também podem causar uma intolerância à lactose transitória. Nos demais casos, a intolerância à lactose desenvolve-se por si só com o passar do tempo. Atingindo idades de 3 a 6 anos as crianças passam naturalmente a produzir menos lactase do que nos dois primeiros anos de vida. Em algumas crianças, a produção continua a diminuir, ou pode cessar totalmente. Os sintomas da intolerância à lactose, frequentemente, surgem na adolescência ou no início da idade adulta. Alguns grupos étnicos como: negros, hispânicos e asiáticos são mais suscetíveis ao desenvolvimento desta intolerância (NASPGHAN, 2010).

Diagnóstico

A intolerância à lactose é uma síndrome clínica composta por um ou mais sintomas como: dor abdominal, diarreia, náusea, flatulência e/ou distensão abdominal após a ingestão de lactose ou de produtos alimentícios contendo lactose. A quantidade de lactose ingerida para que se desencadeie sintomas, varia para cada indivíduo, dependendo da dose de lactose ingerida, do grau de deficiência de lactase e do tipo de alimento com o qual a lactose foi ingerida (TUMAS; CARDOSO, 2008).

A intolerância à lactose pode ser classificada como primária, quando há um defeito intrínseco da enzima; ou secundária, quando ocorre um dano na mucosa intestinal com consequente falta da mesma. Algumas causas do distúrbio primário são: deficiência de lactase do prematuro; deficiência de lactase congênita; e deficiência de lactase do tipo adulto. O distúrbio secundário pode ter como causas: doença celíaca; fibrose cística; alergia à proteína heteróloga; desnutrição; retocolite ulcerativa; síndrome do cólon irritável; giardíase; utilização de algumas drogas; entre outras (TÉO, 2002).

A suspeita diagnóstica pode ser feita pela eliminação de fezes líquidas ou semilíquidas, com pH ácido (menor de 6) ou quando após tomar um copo de leite, o usuário desenvolve distensão abdominal e diarreia aquosa em 20 a 30 minutos. O teste de tolerância à lactose é específico para o distúrbio clínico da deficiência da lactase. Uma dose oral de, aproximadamente, 50g (pouco mais que dois copos, pois cada 200ml de leite integral tem 18g de lactose) de lactose causa diarreia com distensão e desconforto abdominal e a curva glicêmica é baixa ou plana. Quantidades equivalentes de glicose e galactose produzem aumento normal na glicemia sem diarreia. Um aumento de menos de 20mg/dl na glicemia é anormal (CARROCCIO, 1998; DANTAS, 1997).

Tratamento

O tratamento da intolerância à lactose consiste, basicamente, em excluir da dieta os alimentos que contêm lactose (BERKOW, 1989; SILVEIRA, 2003; SHAW, 1999).

É importante lembrar, em particular, que nos usuários com diarreia infecciosa aguda, não se deve administrar lactose, por causa da deficiência transitória de lactase que eles apresentam e a consequente diarreia osmótica que agora poderá ocorrer, mesmo nos dias que se seguem a sua resolução. A reposição hídrica e eletrolítica é importante nestes casos, porém, o “soro caseiro” não

poderá conter a lactose na sua composição pois, poderá acarretar o agravamento dos sintomas (diarreia) (SHAW AD (BERKOW, 1989; SILVEIRA, 2003; SHAW, 1999).

A ingestão de bebidas fermentadas de leite, por exemplo o Kefir, que, à semelhança dos iogurtes, contêm diferentes culturas de lactobacilos, podem melhorar a tolerância à digestão da lactose em adultos (HERTZLER, 2003).

A exclusão dos alimentos aos quais a criança apresenta intolerância é uma forma eficaz no tratamento da patologia, é imprescindível a orientação detalhada dos tipos de alimentos que a criança deve evitar, para que assim seja evitado dietas desnecessárias e muito restritivas, visando garantir a adequada oferta nutricional alcançando as necessidades individuais de cada criança.

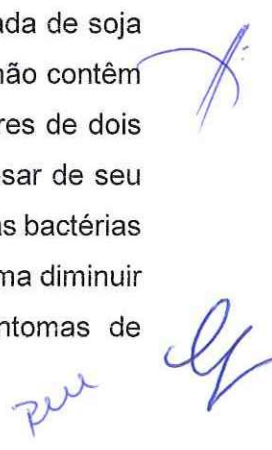
Cuidado Nutricional no tratamento da intolerância à lactose

O cuidado nutricional na intolerância à lactose deve ser iniciado quando o diagnóstico for bem estabelecido, visto que mudanças na ingestão de leite e derivados na dieta de crianças pequenas podem resultar em carências nutricionais que poderão perdurar por toda vida. Não existe cura para a intolerância à lactose, mas podem-se atenuar os sintomas quando leite e seus derivados não são mais ingeridos, ou são ingeridos controladamente e de forma limitada (PACHECO, 2010).

As crianças na primeira infância e os lactentes com deficiência de lactase não devem ingerir fórmulas infantis ou alimentos contendo lactose, até que se tornem capazes de tolerar e digerir a lactose. A restrição parcial ou total da ingestão de leite e seus derivados é suficiente para controlar os sintomas. A ingestão de leite, fracionadas em pequenas porções no decorrer do dia, podem ser toleradas por crianças maiores e adultos, porém esta é uma questão absolutamente individual (TUMAS; CARDOSO, 2008).

São várias as opções para substituição do leite de vaca para a alimentação do lactente. Infelizmente, a maioria delas é totalmente inadequada para as necessidades nutricionais desta faixa etária. Nos lactentes intolerantes à lactose, nenhum outro leite de mamíferos pode substituir o leite de vaca, pois todos contêm lactose. Em nosso meio, o mais comum é o leite de cabra, que estaria contraindicado como substituto. Outras bebidas à base de arroz ou soja são isentos de lactose, porém seu conteúdo nutricional não é equivalente ao do leite de vaca a ponto de poderem substituí-lo (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2006).

Fórmulas infantis isentas de lactose, a base de leite de vaca, são a melhor escolha para a substituição, quando necessário, do leite materno e/ou a fórmula infantil à base de leite de vaca para aquelas crianças intolerantes à lactose. Fórmulas infantis à base de proteína isolada de soja também são uma opção, uma vez que são adequadas às necessidades do lactente e não contêm lactose na sua composição. Estes produtos devem ser consumidos por crianças maiores de dois anos de idade. Queijos e iogurte também são uma opção. O iogurte em especial, apesar de seu alto teor de lactose, pode ser bem tolerado pelos usuários intolerantes à lactose por que as bactérias nele presentes são capazes de digerir a lactose antes do seu consumo. O iogurte costuma diminuir a velocidade do esvaziamento gástrico e do trânsito intestinal, diminuindo os sintomas de intolerância à lactose (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2006).



A retirada de leite e seus derivados é preocupante, por se tratar da maior fonte de cálcio, pois as propriedades deste mineral estão presentes principalmente no crescimento e desenvolvimento na infância e adolescência, por isso é que se deve avaliar o consumo de cálcio pela dieta, que, em casos de deficiência ou baixa ingestão de cálcio, é recomendado que ocorra a suplementação (BUARRAJ et al., 2003).

É indicado o consumo de vegetais de cor verde escura como o brócolis, a couve, o agrião, a mostarda, o repolho, o nabo, peixes que tenham ossos moles como o salmão e sardinhas, mariscos e camarão, que são fontes ricas de cálcio (KAUFMAN, 2005).

Os usuários intolerantes à lactose devem ser orientados a ler os rótulos dos alimentos à serem consumidos, para verificar se há presença de leite e lactose na composição do produto.

Conclusão

O diagnóstico de intolerância a lactose é predominantemente clínico, sendo desnecessário o pedido de Curva de Intolerância à Lactose.

Em casos do usuário ainda apresentar sintomas, mesmo após fazer acompanhamento nutricional de restrição de laticínios e seus derivados, deverá ser encaminhado para avaliação na Atenção Especializada com o médico gastroenterologista.

REFERÊNCIAS

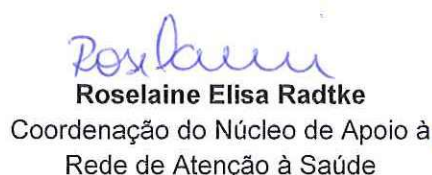
1. AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, Committee on Nutrition. **Lactose Intolerance in Infants, Children, and Adolescents**. Pediatrics, v.118, n.3, p.1279-1286, September 2006.
2. BERKOW, R. Intolerância a carboidratos. In: **Manual Merck de Medicina – diagnóstico e tratamento**. Manual Merck de Medicina. São Paulo – SP: Roca, 1989. p.883-4.
3. BUARRAJ, C. M. et al. **Terapia nutricional na doença inflamatória intestinal**. The Electronic Journal of Pediatric Gastroenterology, Nutrition, and Liver Diseases. São Paulo, v.8, n.4, 2003. Disponível em: <http://www.e-gastroped.com.br/dec04/doenca_inflama_intest.htm>. Acessado em: 06 fev 2012.
4. CARROCCIO, A.; MONTALTO, G.; CAVERA, G.; NOTARBATOLO, A. **Lactose intolerance and self-reportet milk intolerance: relationship with lactose maldigestion and nutrient intake**. Lactase Deficiency Study Group. Journal of the American College of Nutrition, v.17, n.6, p.631-6, december, 1998.
5. DANTAS CORREA, E.B.; DANTAS, W. Diarreias Agudas. In: MINCIS, M. **Gastroenterologia & Hepatologia: Diagnóstico e Tratamento**. São Paulo – SP: Lemos, 1997, p.359-368.
6. HERTZLER, S.R.; CLANCY, S.M. **Kefir improves lactose digestion and tolerance in adults with lactose maldigestion**. Journal of the American Dietetic Association, v.103, n.5, p.582-7, may, 2003.
7. KAUFMAN, D. **Intolerância à Lactose**. Publicado em: 20 nov. 2005. Disponível em: www.dinakaufman.com. Acessado em: 03 fev 2012.
8. SOCIEDADE NORTE-AMERICANA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO (NASPGHAN). **Intolerância à lactose em crianças**. Informe publicado em mar. 2010. Disponível em: <<http://www.naspgghan.org/userassets/Documents/pdf/diseaseInfo/Lactose-P.pdf>>. Acessado em: 06 fev 2012.
9. PACHECO, S. **Contorne a intolerância**. Zero Hora. Porto Alegre – RS: Vida, 07 ago 2010, p.8.

10. PEREIRA FILHO, D.; FURLAN, S. A. **Prevalência de intolerância à lactose em função da faixa etária e do sexo:** experiência do Laboratório Dona Francisca, Joinville (SC). Revista Saúde e Ambiente. *Health and Environment Journal*, v.5, n.1, jun, 2004.
11. PORTO, C. P. C.; THOFERN, M. B.; SOUSA, A. S.; CECAGNO, D. **Experiência vivenciada por mães de crianças com intolerância à lactose.** Família, Saúde e Desenvolvimento. Curitiba – PR: 2005. v.7, n.3, p.250-256, set/dez, 2005.
12. SHAW, A.D.; DAVIES, G. J. **Lactose intolerance:** problems in diagnosis and treatment. *Journal of Clinical Gastroenterology*, v.28, n.3, p.208-16, may, 1999.
13. SILVEIRA, T. R.; PRETTO, F. M. **Intolerância à lactose:** diagnóstico e tratamento Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Porto Alegre – RG: 2003.
14. TEO, C. R. P. A. **Intolerância à lactose:** uma breve revisão para o cuidado nutricional. Arquivos de Ciências da Saúde da Unipar. Toledo – PR: 2002. v.3, n.6, p.135-140, 2002.
15. TUMAS, R.; CARDOSO, A. L. **Como conceituar, diagnosticar e tratar a intolerância à lactose.** Revista Brasileira de Clínica e Terapêutica. São Paulo – SP: 2008. v.34, n.1, edição: fev, 2008.

Elaboração: Marlon Willfried Fritze Soares – Médico Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde



Keli Bett
Gerência de Gestão Estratégica



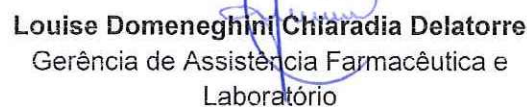
Roselaine Elisa Radtke
Coordenação do Núcleo de Apoio à
Rede de Atenção à Saúde



Marlon Willfried Fritze Soares
Núcleo de Apoio à Rede de Atenção
à Saúde



Luana Garcia Ferrabone
Diretoria Técnica Médica



Louise Domeneghini Chiaradia Delatorre
Gerência de Assistência Farmacêutica e
Laboratório